



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**

Мін'юст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001

тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83

Email: callcentre@ca.minjust.gov.ua,

themis@ca.minjust.gov.ua,

Web: <http://www.minjust.gov.ua>,

код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Органам влади за списком

Щодо виконання рішення Європейського суду
з прав людини у справі «Співак проти України»

05 червня 2025 року Європейським судом з прав людини (далі – Європейський суд) було ухвалено рішення у справі «Співак проти України» (заява № 21180/15), яке набуло статусу остаточного 05 вересня 2025 року.

У цій справі Європейський суд констатував порушення пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) у зв'язку з незаконним триманням заявника під вартою в лікарні, після ухвали суду про припинення його примусового стаціонарного психіатричного лікування; пункту 4 статті 5 Конвенції у зв'язку з відсутністю у заявника можливості оскаржити законність його примусового тримання під вартою у психіатричній лікарні; статті 3 Конвенції у зв'язку з тим, що тримання заявника в психіатричній лікарні, примусове введення нейрорептиків разом із тривалістю тримання його під вартою, затримкою у виписці та неналежними умовами тримання становило жорстоке поводження;; статті 13 у поєднанні зі статтею 3 Конвенції у зв'язку з відсутністю у заявника ефективних засобів юридичного захисту у зв'язку з його скаргами за статтею 3 Конвенції (стислий виклад рішення додається).

Загальна сума грошових коштів, яку Уряд України повинен сплатити на виконання зазначеного рішення Європейського суду, становить 27 950 євро.

Відповідно до пункту 1 статті 46 Конвенції та статті 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» рішення Європейського суду є обов'язковими для виконання.

Під виконанням рішення Європейського суду слід розуміти виплату відшкодування, а також вжиття державою додаткових заходів індивідуального характеру, спрямованих на усунення конкретного порушення, визначеного в рішенні Європейського суду; та заходів загального характеру, спрямованих на усунення підстави для надходження до Європейського суду аналогічних заяв проти України у майбутньому.



СЕД АСКОД

Міністерство юстиції України

№ 136377/158922-21-25/5.2.2 від 19.09.2025

Підписувач Сокоренко Маргарита Степанівна

Сертифікат 382367105294AF9704000000AFB100002D444803

Дійсний з 25.12.2024 10:15:01 по 25.12.2025 10:15:01

За цими критеріями КМ РЄ здійснює оцінку виконання державою рішень Європейського суду, виходячи з інформації, наданої державними органами щодо заходів, вжитих на виконання вказаних рішень. Відповідні положення закріплені у Правилах Комітету міністрів Ради Європи щодо контролю за виконанням рішень Європейського суду та умов дружнього врегулювання (10 травня 2006 року).

Обсяг та суть заходів загального та індивідуального характеру, необхідних для виконання кожного конкретного рішення Європейського суду, безпосередньо залежать від характеру порушень, констатованих Європейським судом.

У рішенні «Співак проти України» Європейський суд зазначив: «...що національні суди визнали примусову госпіталізацію заявника з 24 до 28 жовтня 2014 року незаконною та присудили йому близько 256 євро як відшкодування шкоди» (пункт 126 рішення). Також зауважив що «...присуджена сума значно нижча за ті, що Суд зазвичай присуджує у подібних справах, і не може вважатися належним відшкодуванням» (пункт 127 рішення), «...свавільне тримання під вартою в психіатричній лікарні пацієнта, примусове стаціонарне психіатричне лікування якого було припинене судом, становило серйозне порушення права на свободу, закріпленого у статті 5 Конвенції» (пункт 130 рішення).

Європейський суд повторив «що згідно з його практикою особа, піддана примусовому лікуванню, повинна мати доступ до суду та можливість бути заслуханою особисто або через представника. Перегляд законності тримання під вартою за пунктом 4 статті 5 Конвенції не повинен бути автоматичним, а радше повинен надавати можливість пацієнтам самостійно ініціювати провадження (див. рішення у справі «Горшков проти України» (*Gorshkov v. Ukraine*), заява № 67531/01, пункт 39, від 08 листопада 2005 року з подальшими посиланнями). Таким чином, пункт 4 статті 5 Конвенції вимагає насамперед надання незалежної правової допомоги, яка забезпечить затриманому можливість постати перед суддею, який ухвалюватиме рішення про законність подальшого тримання під вартою. Доступ затриманого до судді не повинен залежати від доброї волі органу державної влади, який здійснює тримання під вартою, і надаватися на розсуд медичного персоналу або адміністрації лікарні» (пункт 136 рішення).

«Згідно з фактами цієї справи, ніщо не свідчить, що до 13 жовтня 2014 року районний суд критично оцінював подання Дніпропетровської лікарні перед задоволенням її клопотання про дозвіл на продовження примусового лікування заявника. Ухвали районного суду були майже однаковими кожного разу, не містили детального обґрунтування та по суті повторювали висновки оцінки Дніпропетровської лікарні без проведення будь-якого незалежного аналізу, аби визначити, чи справді заявник страждав на психічний розлад

такого характеру та ступеня, що виправдовував продовження його примусового тримання під вартою» (пункт 142 рішення).

«Крім того, районний суд постановляв свої ухвали, не побачивши заявника особисто, не спостерігаючи за його поведінкою та не вислухавши його точку зору, тоді як національні процесуальні норми, в принципі, вимагали присутності заявника у засіданнях» (пункт 145 рішення).

Додатковим свідченням якості судового перегляду та небажання суддів ставити під сумнів медичні висновки став висновок Омбудсмена у доповіді за 2015 рік, що районний суд розглянув сорок п'ять справ за один день, усі за відсутності відповідних пацієнтів і суд обґрунтував свої ухвали виключно висновками лікарні.

«З огляду на наведене Суд вважає, що розгляд, який здійснював районний суд до 13 жовтня 2014 року за відсутності заявника, характеризувався явною недбалістю суду та був несумісним з основними вимогами правосуддя» (пункт 148 рішення).

Європейський суд вважав «що держави мають позитивні зобов'язання за статтею 3 Конвенції, які включають, по-перше, зобов'язання створити законодавчу та нормативно-правову базу для захисту; по-друге, за певних чітко визначених обставин зобов'язання вживати оперативних заходів для захисту конкретних осіб від ризику застосування поводження, яке суперечить цьому положенню; та, по-третє, зобов'язання проводити ефективне розслідування небезпідставних скарг про застосування такого поводження. Загалом, перші два аспекти цих позитивних зобов'язань класифікуються як «матеріальні», тоді як третій аспект відповідає позитивному «процесуальному» зобов'язанню держави» (пункт 171 рішення).

Також наголосив, «що навіть коли примусові заходи медичного характеру вважаються необхідними, вони повинні підлягати суворому нагляду, аби запобігти потенційним зловживанням та забезпечити пропорційність і виправданість втручання в особисту автономію. Зокрема, важливо, щоб надане лікування було належним та необхідним. Без таких гарантій автоматичне схвалення лікування без згоди ризикує підірвати права особи у такий спосіб, що це може бути несумісним з принципом верховенством права в демократичному суспільстві» (пункт 176 рішення).

«Розглянувши зазначені елементи, Суд вважає, що чинна на той момент законодавча база України не відповідала вимозі, властивій позитивному зобов'язанню держави створити та ефективно застосовувати систему, що забезпечувала б захист пацієнтів, які проходять примусове лікування в психіатричних закладах, від порушень їхньої недоторканності, всупереч статті 3 Конвенції. Відсутність належних юридичних гарантій позбавила заявника мінімального ступеня захисту, на який він мав право згідно з принципом верховенства права в демократичному суспільстві (див., *mutatis mutandis*, згадане рішення у справі «Херцегфальві проти Австрії» (*Herczegfalvy v.*

Austria), пункт 91 та рішення у справі «Нарінен проти Фінляндії» (*Narinen v. Finland*), заява № 45027/98, пункт 36, від 01 червня 2004 року; див. також згадане рішення у справі «Х. проти Фінляндії» (*X v. Finland*), пункт 221)» (пункт 189 рішення).

«Стосовно існування терапевтичної необхідності тривалого перебування заявника в психіатричній лікарні та психіатричного лікування нейрорептиками, Суд зазначає, що у зв'язку з відсутністю зазначених процесуальних гарантій та як наслідок непроведення належним чином органами досудового розслідування розгляду відповідних тверджень заявника після його виписки (див. пункт 188), він не може скористатися оцінкою чи висновком, які могли бути зроблені на національному рівні у зв'язку з цим. Таке непроведення розслідування вплинуло на цілісність та достовірність подальшої оцінки, здійсненої апеляційним судом у провадженні щодо відшкодування шкоди, яка не врахувала обмежену здатність заявника збирати докази. До того ж цивільний суд не взяв до уваги твердження заявника щодо його лікування як його суто суб'єктивні уявлення, не врахував критичну важливість його свідчень з перших вуст та, вочевидь, не розглянув його історію хвороби, що ще більше підриває достовірність його висновків. Суд також не може покладатися на оцінку, здійснену районним судом до жовтня 2014 року, враховуючи недоліки цього провадження...» (пункт 190 рішення).

«Оскільки єдиним станом, згаданим у всіх документах, був стан сутінкового розладу свідомості – окремий випадок, що завершився, спричинений алкогольним сп'янінням, який стався за понад рік до госпіталізації заявника та більше ніколи не повторювався, до березня 2013 року медична підстава для його перебування в лікарні залишалася незрозумілою. Крім того, через вісім днів після його госпіталізації, 14 грудня 2012 року, заявнику – дієздатній особі – почали без його згоди давати нейрорептичні препарати. Це лікування, яке щодня застосовувалося в різних формах, дозуваннях і без заздалегідь призначеного курсу, тривало протягом усієї його госпіталізації, навіть після того, як 13 жовтня 2014 року районний суд постановив ухвалу про припинення застосування примусових заходів медичного характеру» (пункт 193 рішення).

«З історії хвороби та інформаційної довідки Дніпропетровської лікарні, наданої Уряду (див. пункти 46 і 47), випливає, що нейрорептики були призначені у відповідь на поведінку заявника. Однак, матеріали справи не містять достовірних доказів, і це було підтверджено районним судом в його ухвалі від 13 жовтня 2014 року (див. пункт 17), які б вказували на прояви гострих психотичних симптомів під час його перебування в лікарні, таких як галюцинації, марення, небезпечно агресивна поведінка або рецидивуючий сутінковий розлад свідомості», «...призначення нейрорептиків та зміни у формі введення та дозуванні, збіглися за часом та відбулися після відмови заявника визнати свою провину у вчиненому злочині, оскільки він не міг

згадати деталей, його послідовних тверджень, що він психічно здоровий, його наполегливих запитань про необхідність подальшої госпіталізації та лікування, його скарг на «проблеми з триманням під вартою» та висловленого ним розчарування у зв'язку з цим. Ці реакції були цілком нормальними для людини в становищі заявника; проте лікарня представила їх як небезпечні прояви психічного захворювання, що вимагали тривалого лікування в закладі із суворим наглядом, і супроводжувалися безперервним застосуванням нейролептиків. Суду не отримав задовільного пояснення, чому розчарування заявника викликало таку реакцію», «...ця ситуація чітко вказує на каральний, а не терапевтичний характер мотивів для тримання заявника під вартою в лікарні та лікування його нейролептиками» (пункти 195-197 рішення).

Європейський суд також зауважив, що «...нейролептиками зазвичай вважається клас препаратів, що використовуються для лікування психотичних станів, таких як шизофренія, зокрема, таких симптомів, як марення та галюцинації. З огляду на їхній значний вплив на центральну нервову систему та ризик серйозних побічних ефектів, включаючи порушення обміну речовин, розлади руху та седативний ефект, їхнє використання викликає занепокоєння у випадку відсутності підтвердженого діагнозу важкого психотичного розладу, який може становити небезпеку для пацієнта або інших осіб. Правові документи та доповіді, прийняті Організацією Об'єднаних Націй, вказують, що застосування нейролептиків без медичної необхідності може становити жорстоке поводження, яке заборонене Конвенцією ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання» (пункт 201 рішення).

На підставі зазначеного Європейський суд прийшов до висновку, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв'язку з невпровадженням необхідної законодавчої та нормативно-правової бази, яка б регулювала примусові заходи медичного характеру в психіатричних закладах, зокрема щодо розслідування скарг на застосування таких заходів, а також у зв'язку з фактичним лікуванням, якого зазнав заявник, у тому числі відсутність належної відповіді органів державної влади на порушені ним питання та невжиття оперативних заходів для його захисту.

Європейський суд зазначив, що «..протягом майже дворічного перебування заявника у Дніпропетровській лікарні він тримався в умовах переповненості з обмеженим доступом до туалетів та ванних кімнат, а також з обмеженими можливостями для здійснення прогулянок на свіжому повітрі. Наявні матеріали свідчать, що ці умови не обмежувалися індивідуальною ситуацією заявника, а мали структурний характер. Сукупний ефект цих умов мав спричинити душевні страждання та труднощі, які перевищували поріг суворості, передбачений статтею 3 Конвенції. Отже, було порушено це положення у зв'язку з умовами тримання під вартою» (пункт 207 рішення).

Також Європейський суд встановив, що «...держава - відповідач не запровадила належної законодавчої та нормативно-правової бази та не вжила оперативних заходів захисту, зокрема у відповідь на скарги (див. пункти 178 – 187), а також з огляду на свій висновок, наведений у пунктах 188 і 190, Суд вважає, що у заявника не було ефективного національного засобу юридичного захисту у зв'язку з його скаргами за статтею 3 Конвенції. Тому Суд вважає, що у цій справі також було порушено статтю 13 у поєднанні зі статтею 3 Конвенції» (пункт 211 рішення).

З огляду на зазначене, а також на характер порушень, встановлених Європейським судом у справі «Співак проти України», з метою забезпечення належного виконання рішення Європейського суду у цій справі та попередження аналогічних порушень у майбутньому в межах компетенції прошу:

1) врахувати зазначену інформацію в роботі та довести висновки Європейського суду у вказаній справі до відома суддів усіх рівнів;

2) суддям належним чином розглядати заяви представників закладів з надання психіатричної допомоги (лікарів-психіатрів) щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, ретельно перевірити достовірність аргументів, отримувати інші незалежні медичні висновки щодо стану осіб, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру, детально обґрунтовувати рішення по суті та не повторювати висновки оцінки лікарень без проведення будь-якого незалежного аналізу та вивчення історії хвороби відповідних осіб. Також з метою досягнення належного розуміння стану таких осіб та встановлення факту, чи становлять вони небезпеку для інших осіб, забезпечувати присутність їх в судових засіданнях, спостерігати за їх поведінкою та брати до уваги їх твердження, враховуючи критичну важливість таких свідчень та обмежену здатність цих осіб збирати докази.

3) Міністерству охорони здоров'я України – належним чином здійснювати державний контроль за діяльністю закладів з надання психіатричної допомоги та фахівців, інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, зокрема, з метою недопущення незаконного тримання особи в закладах з надання психіатричної допомоги;

- врахувати зазначену інформацію в роботі та довести висновки Європейського суду у вказаній справі до відома співробітників закладів психіатричної допомоги, зокрема щодо недопустимості примусового тримання особи у лікарні без законних підстав, звернувши їхню увагу на необхідність дотримання положень Конвенції, практики Європейського суду та національного законодавства, принципів законності, гуманності, та додержання прав людини і громадянина під час надання психіатричної допомоги;

4) Офіс Генерального прокурора – належним чином здійснювати нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а

також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян; ретельно розслідувати скарги осіб на постановки їм неправильного діагнозу та застосування непотрібного примусового лікування із застосуванням медичних препаратів, нейролептиків; під час розслідувань таких справ відвідувати осіб, які перебувають на примусовому лікуванні в спеціалізованих медичних закладах.

5) Прокуратурі Дніпропетровської області – повідомити про результати розслідування кримінального провадження № 42015040680000016 за скаргою заявника Співака Геннадія Ігоровича. Які дії вживаються для швидкого та повного розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Якщо відповідне кримінальне провадження закрито, прошу надати підтверджуючі документи (зокрема постанову про закриття кримінального провадження), а також повідомити, чи оскаржували заявник або його представник таке рішення та який результат розгляду скарги.

6) Довести висновки Європейського суду у цій справі до відома працівників органів досудового розслідування з метою забезпечення проведення у майбутньому ефективного досудового розслідування відповідно до практики Європейського суду.

7) Національну академію внутрішніх справ України, і Тренінговий центр прокурорів України – забезпечити включення рішення Європейського суду у цій справі до програм підготовки та підвищення кваліфікації працівників національної поліції та прокуратури.

8) Національну школу суддів України – забезпечити включення рішення Європейського суду у цій справі до програм підготовки та підвищення кваліфікації суддів всіх рівнів.

З метою забезпечення належного звітування КМ РС прошу повідомити про результати розгляду цього листа до **20 жовтня 2025 року**.

Крім того повідомляю, що найближчим часом автентичний переклад вказаного рішення буде надрукований у збірнику нормативно-правових актів «Офіційний вісник України», розміщено на офіційному сайті Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/cat_9329 та в офіційній базі даних Європейського суду HUDOC <https://hudoc.echr.coe.int>.

Додаток: 1. Стислий виклад рішення Європейського суду у вказаній справі усім адресатам. 2. Копія автентичного перекладу вказаного рішення Верховному Суду. 3. Копія перекладу українською мовою вказаного рішення Офісу Генерального прокурора.

**Уповноважений у справах
Європейського суду з прав людини**

Маргарита СОКОРЕНКО

Список

Верховний Суд – вул. П. Орлика, буд. 8, м. Київ, 01043;

Офіс Генерального прокурора – вул. Різницька, буд. 13/15, м. Київ, 01011;

Міністерство внутрішніх справ України – вул. Академіка Богомольця, буд. 10,
м. Київ, 01601;

Міністерство охорони здоров'я України – вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601;

Національна поліція України – вул. Академіка Богомольця, буд. 10, м. Київ, 01601;

Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області - vdz@dp.police.gov.ua

Дніпропетровська обласна прокуратура - пр-т Дмитра Яворницького, 38, м. Дніпро, 49044;

Дніпровський апеляційний суд – inbox@dpa.court.gov.ua;

Чечелівський районний суд м. Дніпра – inbox@kg.dp.court.gov.ua;

Дніпровська філія «Спеціальний заклад з надання психіатричної допомоги» Державної установи «Інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров'я України» - вул. Алексеєнко Надії, будинок 84, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49006;

Тренінговий центр прокурорів України – вул. Юрія Іллєнка, буд. 81-б, м. Київ, 04050;

Національна академія внутрішніх справ – пл. Солом'янська, буд. 1, м. Київ – ДСП, 03035.

Національна школа суддів України – вул. Жилянська, буд. 120 А, м. Київ, 01032.